

Протокол операции отделения ЭФИ

Ф. И. О. пациента					
История болезни		Дата рождения	24.07.1966	Отделение	ЭФИ
Дата Процедура /исследование/	24.07.2023	Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) и радиочастотная абляция “медленных путей” АВ-соединения.			

Исходно регистрируется синусовый ритм с ЧСС 70 уд в мин.

Сначала операционная поля (место пункции) обработано с бетадином и спиртом. Далее под местной анестезией Sol.Novocaini 0,5% - 20,0 мл по методике Сельдингера с помощью иглы дважды пропунктирована правая бедренная вена, через которые с помощью интродьюсеров в полость сердца проведены 2 электрода для проведения ЭФИ в позиции CS и Гис.

На синусовом ритме проведено ЭФИ:

При программном и учащающем стимуляции индуцирован тахикардия с ДЦ=353 мс (ЧСС 170 уд/мин) типичный с АВУРТ.

Радиочастотная абляция

С помощью картирующего-абляционного электрода в LAO=30° выполнена модификация АВ узлового проведения: выполнено 3 эффективных воздействия в правой среднесептальной области с параметрами: P = 30-40 Вт; t = 50-55°C; I = 95-110 Ohm и длительностью по 60 сек, во время которых регистрировался медленный ритм из АВ-соединения.

Далее выполнено ЭФИ:

Ретроградная точка Венкебаха = 140 уд в мин.

РЭРП АВУ = 300 мсек.

Антеградная точка Венкебаха = 190 уд в мин.

АЭРП АВУ = 270 мсек.

Далее введено Атропин 0,1%-0,5 мл и проведено контрольное ЭФИ:

Ретроградная точка Венкебаха = 160 уд в мин.

РЭРП АВУ = 280(120) мсек.

Антеградная точка Венкебаха = 220 уд в мин.

АЭРП АВУ = 200(120) мсек.

Проведение через системы Гиса-Пуркинье. Тахикардия методами учащающей и программированной стимуляции не индуцируется.

На этом процедура была завершена. Деканюляция. Гемостаз. Асептические наклейки на места пункций. Пациент переведен в отделение на синусовом ритме.

Назначения:

1. Постельный режим – 12 ч.
2. Наблюдение дежурного врача.
3. ЭКГ мониторинг и контроль.